

# Çocuklarda Kronik İshal — Değerlendirme Algoritması

≥ 2–4 hafta süren ishalde yaşa ve fizyopatolojik mekanizmaya göre yaklaşım: önce büyümeyi ve alarm bulgularını değerlendir, ozmotik/sekretuar ayrımını yap, hedefe yönelik tetkik et.

Kronik ishal ≥ 2–4 hafta

Ozmotik / Sekretuar / İnflamatuar

0–18 yaş

Malabsorpsiyon

## 01 Tanım ve ilk değerlendirme

**Kronik ishal** = ≥ 14 gün (çoğu kaynakta ≥ 4 hafta) süren, dışkı sıklığı ve/veya su içeriğinde artış. İlk soru: **çocuk büyüyor mu?** Büyüme geriliği ve alarm bulguları organik/malabsorptif nedeni işaret eder.

### Öykü

- Süre, başlangıç yaşı, sıklık, **dışkı özelliği** (sulu / yağlı / kanlı-mukuslu).
- Beslenme: **aşırı meyve suyu/sorbitol**, yeni gıdalar, glüten, süt.
- Gece ishali, karın ağrısı, kilo/iştah, ateş, döküntü, seyahat.
- Antibiyotik öyküsü, aile öyküsü (çölyak, IBD, KF, immün yetmezlik).

### Muayene

- Büyüme eğrisi** ve hidrasyon/ödem (protein kaybı).
- Karın distansiyonu, kitle, perianal hastalık (fistül/fissür → IBD).
- Çomak parmak, döküntü, aftöz lezyon, artrit (ekstraintestinal).
- Cilt altı yağ, kas kütlesi (kronik malnütrisyon işaretleri).

## Mekanizmaya göre sınıflama

Fizyopatoloji tetkiki yönlendirir. Basit ipucu: **açlıkla düzelen** ishal ozmotik, **açlıkta süren** ishal sekretuardır.

### Ozmotik

*Açlıkla düzelir · dışkı pH < 5.5, redüktan madde (+), ozmotik aralık ↑*

Karbonhidrat malabsorpsiyonu (laktoz, sukraz-izomaltaz), aşırı meyve suyu/sorbitol, laksatif.

### Sekretuar

*Açlıkta sürer · bol sulu, ozmotik aralık düşük*

Enfeksiyon toksinleri, konjenital diyareler, nöroendokrin tümör, safra asidi.

### İnflamatuvar

*Kan/mukus · kalprotektin ↑, CRP/ESR ↑*

İnflamatuvar bağırsak hastalığı, alerjik kolit, invaziv/kronik enfeksiyon.

### Yağ malabsorpsiyonu

*Yağlı-kokulu dışkı · elastaz ↓, dışkı yağı ↑*

Çölyak, kistik fibrozis / pankreas yetmezliği, kolestaz, kısa bağırsak.

### 03 Karar akışı

Büyüme + alarm değerlendir → sağlıklı büyüyende sık iyi huylu nedenler → aksi halde mekanizmaya göre basamaklı tetkik → tanı yoksa sevk/endoskopi.

#### BAŞLANGIÇ

#### ≥ 2-4 hafta süren ishal

Öykü, beslenme, dışkı özelliği ve büyüme eğrisini değerlendir.

#### KARAR 1

#### Büyüme geriliği veya alarm bulgusu var mı?

Kilo kaybı/duraklama, kanlı dışkı, gece ishali, dehidratasyon, ödem, ateş, perianal hastalık (bkz. bölüm 05).

HAYIR → sağlıklı büyüyor

EVET → organik tetkik

#### SIK İYİ HUylu NEDENLER

#### Diyet öyküsünü gözden geçir

**Toddler ishali** (kronik nonspesifik), aşırı meyve suyu/sorbitol, geçici post-enfeksiyöz laktoz intoleransı. Diyet düzenle + izle.

#### YÖNLENDİR

#### Basamaklı tetkike geç

Dışkı özelliği ve mekanizmaya göre hedefe yönelik test iste.

#### ADIM 1 · 1. BASAMAK

#### Dışkı + kan tetkikleri

**Dışkı:** kültür, parazit/Giardia antijeni, gizli kan, **kalprotektin**, pH + redüktan madde, elastaz. **Kan:** TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, **çölyak serolojisi** (doku transglutaminaz IgA + total IgA), TSH.

#### KARAR 2

#### Yönlendirici bulgu var mı?

EVET → nedene yönelik

HAYIR / kalıcı → 2. basamak

#### YÖNET

#### Tanıya göre tedavi

Çölyak → glütensiz diyet; Giardia → tedavi; laktoz intoleransı → diyet; alerjik → eliminasyon. Yanıtı doğrula.

#### ADIM 2 · 2. BASAMAK

#### Genişletilmiş tetkik

**Ter testi** (KF), immünglobulinler, IBD göstergeleri, endokrin/metabolik, gerekirse

dışkı ozmotik aralığı ve nöroendokrin  
belirteçler.

### KARAR 3

**Tanı hâlâ belirsiz / IBD veya konjenital şüphesi?**

**EVET → sevk / endoskopi**

#### İLERİ

**Pediatric gastroenterolojiye yönlendir**

Üst/alt endoskopi + biyopsi, görüntüleme; süt  
çocuğunda konjenital ishal için genetik tetkik.

**HAYIR → izlem**

#### İZLEM

**Büyüme ve semptom takibi**

Diyet ampirik denemesi + yakın izlem;  
kötüleşme/yeni alarm → yeniden  
değerlendir.

| Hedefe yönelik laboratuvar / işlemler |                               |                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BASAMAK                               | HEDEF                         | TESTLER                                                                          |
| <b>Dışkı</b>                          | Enfeksiyon                    | Kültür, Giardia/Cryptosporidium antijeni, parazit yumurta, (C. difficile seçili) |
| <b>Dışkı</b>                          | İnflamasyon                   | Fekal <b>kalprotektin</b> , gizli kan, lökosit                                   |
| <b>Dışkı</b>                          | Malabsorpsiyon tipi           | pH + redüktan madde (ozmotik), dışkı elastazı (pankreas), dışkı yağı             |
| <b>Kan</b>                            | Genel + beslenme              | TKS, CRP/ESR, elektrolit, albümin, demir, çinko, vitaminler                      |
| <b>Kan</b>                            | Çölyak                        | Doku transglutaminaz IgA + total IgA                                             |
| <b>Kan</b>                            | Endokrin                      | TSH (± hipertiroidi taraması)                                                    |
| <b>2. basamak</b>                     | Kistik fibrozis               | Ter testi (± genetik)                                                            |
| <b>2. basamak</b>                     | İmmün yetmezlik               | İmmünglobulinler (IgG/A/M), lenfosit alt grupları                                |
| <b>3. basamak</b>                     | IBD / mukozal                 | Üst + alt endoskopi ve biyopsi, görüntüleme (MR enterografi)                     |
| <b>3. basamak</b>                     | Konjenital ishal (süt çocuğu) | Dışkı elektrolit/ozmotik aralık, genetik panel, nöroendokrin belirteçler         |

**Toddler ishali** (6 ay–5 yaş, iyi büyüyen, ekstra tetkik gerektirmeyen): "4 F" düzenlemesi — aşırı **meyve suyu** (fruktoz/sorbitol) azalt, yeterli **yağ**, normal **lif**, aşırı **sıvıyı** sınırla. Genellikle 4 yaş civarı kendiliğinden geriler.

05

**Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)**

- **Büyüme geriliđi** / kilo kaybı / duraklama

- **Kanlı veya mukuslu dışkı**

- **Gece ishali** (uykudan uyandıran)

- Dehidratasyon, elektrolit bozukluđu

- **Ödem** / hipoalbüminemi (protein kaybı)

- Sürekli ateş, sistemik hastalık bulgusu

- **Perianal hastalık** (fistül, fissür, apse) → IBD

- Ekstraintestinal: artrit, döküntü, aftöz ülser, üveit

- Süt çocuđuunda **doğumdan itibaren** ağır sulu ishal (konjenital)

- Tekrarlayan/ağır enfeksiyon (immün yetmezlik)

06

**Yaş a özgü en sık nedenler****Süt çocuđu (< 1 yaş)**

- **İnek sütü/besin protein alerjisi**, post-enfeksiyöz ishal.
- Doğumdan itibaren ağır sulu ishalde **konjenital ishaller** (mikrovillus inklüzyon, tufting, konjenital klor/sodyum ishali).
- **Kistik fibrozis**, primer immün yetmezlik.

**Toddler / okul çađı / ergen**

- **Toddler ishali** (kronik nonspesifik), post-enfeksiyöz laktoz intoleransı, Giardia.
- **Çölyak** hastalığı her yaş ta düşünölmeli.
- Okul çađı/ergende **IBD** (Crohn, ülseratif kolit) ve İBS.

Herhangi bir **alarm bulgusu****Büyüme geriliği** / malnütrisyonKanlı ishal / **IBD** şüphesi

1. basamak tetkik tanısız + kalıcı

Süt çocuğunda **konjenital ishal** şüphesi

Endoskopi/biyopsi gerektiren durum

**Uyarı:** Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik seçimi çocuğun yaşı, büyümesi ve klinik gidişine göre bireyselleştirilmelidir.

#### Kaynaklar

1. Zella GC, Israel EJ. Chronic Diarrhea in Children. *Pediatr Rev.* 2012;33(5):207–218.
2. Guarino A, Lo Vecchio A, Berni Canani R. Chronic diarrhoea in children. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2012;26(5):649–661.
3. Thiagarajah JR, Kamin DS, Acra S, ve ark. Advances in Evaluation of Chronic Diarrhea in Infants. *Gastroenterology.* 2018;154(8):2045–2059.
4. Hill ID, Fasano A, Guandalini S, ve ark. NASPGHAN Clinical Report on Celiac Disease. *JPGN.* 2016;63(1):156–165.